友邦人寿[2026]疾病保险 046 号

请扫描以查询验证条款

友邦附加悠享提前给付重大疾病保险

在本条款中，“您”指投保人，“我们”、“本公司”均指友邦人寿保险有限公司。

第一条　附加合同的订立和构成

《友邦附加悠享提前给付重大疾病保险》合同（以下简称本附加合同），依其所附加于的主保险合同（以下简称主合同）投保人的申请，经我们同意而订立。主合同的条款也适用于本附加合同，若本附加合同的条款与主合同的条款互有冲突，则以本附加合同条款为准。

第二条　附加合同的成立与生效

您提出保险申请且我们同意承保，本附加合同成立。

若您选择投保本附加合同，则本附加合同须与主合同同时投保，并与主合同同时生效，以主合同的生效日为本附加合同的生效日。

除另有约定外，我们自本附加合同生效日 24 时开始承担保险责任。

第三条　投保范围

本附加合同接受的被保险人的投保年龄范围为 25 **周岁**（释义一）至 55 周岁，且须符合投保当时我们的规定。

第四条　犹豫期

自您签收本附加合同之日起，有 15 日的犹豫期。在此期间请您认真审视本附加合同，如果您认为本附加合同与您的需求不相符，您可以在此期间提出解除本附加合同，我们将退还您所支付的全部保险费。

解除本附加合同时，您需要填写解除合同通知书，并提供您的保险合同及**有效身份证件**（释义二）。自我们收到您解除合同的通知书时，本附加合同即被解除，**合同解除前发生的保险事故我们不承担保险责任。**

第五条　保险期间

本附加合同的保险期间为被保险人终身。

第六条　基本保险金额与累积交清增额保险金额

本附加合同基本保险金额等于主合同基本保险金额，并在保险单上载明。**若该金额发生变更，则以变更后的金额为基本保险金额。**

本附加合同的累积交清增额保险金额是指本附加合同因主合同红利分配而选择用现金红利购买本附加合同的交清增额保险而累积增加的保险金额。本附加合同的累积交清增额保险金额等于主合同的累积交清增额保险金额。

若本附加合同已给付重度疾病保险金，则主合同的基本保险金额和累积交清增额保险金额分别按本附加合同约定的相应金额等额减少。

第七条　保险责任

本附加合同的保险责任分为基本部分和可选部分。您可以单独投保基本部分，也可以在投保基本部分的基础上同时投保可选部分，**但不能单独投保可选部分。**您选择的保险责任在保险单上载明。

在本附加合同保险期间内，我们按照约定承担给付相应保险金的保险责任。

一、等待期

本附加合同生效日起或最后一次效力恢复之日起的180日内（含第180日）为本附加合同重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、中度疾病保险金、轻度疾病保险金的等待期。若被保险人在等待期内被确诊患有本附加合同约定的重度疾病（释义三）、中度疾病（释义四）、轻度疾病（释义五），则我们不承担给付相应的重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、中度疾病保险金、轻度疾病保险金的保险责任。

若被保险人因**意外事故**（释义六）发生前述情形的，无等待期。

二、基本部分

1.重度疾病保险金

本附加合同所承保的重度疾病共有40种，具体疾病名称及疾病定义可于本附加合同附表一中查询。

若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因就诊并被**专科医生**（释义七）首次确诊患有本附加合同约定的重度疾病，则我们将给付重度疾病保险金，其金额等于该重度疾病确诊时本附加合同的基本保险金额与累积交清增额保险金额之和。

本附加合同的重度疾病保险金给付以一次为限。重度疾病保险金给付后本附加合同终止。

2.特别保障保险金

对于本附加合同的重度疾病特别保障保险金、全残特别保障保险金、身故特别保障保险金，我们仅给付一项，并以一次为限，且以最先发生者予以给付。最先发生时日以下列约定为准。

本附加合同中特别保障保险金的保障期可为以下两种，由您在投保时与我们约定，并在保险单上载明。**保障期不可变更。**

（1）在本附加合同生效日后的第 35 个**保单周年日**（释义八）（若保单周年日与被保险人生日是同一日期，则为被保险人相应生日，下同）以前；

（2）在本附加合同生效日后至被保险人年满 65 周岁后的首个保单周年日以前。

2.1 重度疾病特别保障保险金

在本附加合同的特别保障保险金保障期内，若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因就诊并被专科医生首次确诊患有本附加合同约定的重度疾病，则我们除给付上述重度疾病保险金外，还将给付重度疾病特别保障保险金，其金额等于该重度疾病确诊时本附加合同基本保险金额的 50%（百分之五十）。

2.2 全残特别保障保险金

在本附加合同的特别保障保险金保障期内，若被保险人**全残**（释义九），则我们将给付全残特别保障保险金，其金额等于被保险人全残发生时本附加合同基本保险金额的 50%（百分之五十）。

全残特别保障保险金给付后本附加合同终止。

2.3 身故特别保障保险金

在本附加合同的特别保障保险金保障期内，若被保险人身故，则我们将给付身故特别保障保险金，其金额等于被保险人身故时本附加合同基本保险金额的 50%（百分之五十）。

三、可选部分

1.中度疾病保险金

本附加合同所承保的中度疾病共有5种，具体疾病名称及疾病定义可于本附加合同附表二中查询。

若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因就诊并被专科医生首次确诊患有本附加合同约定的中度疾病，则我们将给付中度疾病保险金，其金额等于该中度疾病确诊时本附加合同基本保险金额的60%（百分之六十）。**同一种中度疾病仅给付一次，中度疾病保险金累计给付以三次为限**。当累计给付的中度疾病保险金达到三次时，本项保险责任终止，本附加合同继续有效。

若被保险人因同一疾病或同一意外事故导致其发生本附加合同约定的两种或两种以上的中度疾病，则我们仅对其中一种中度疾病给付中度疾病保险金。

若被保险人因同一疾病或同一意外事故导致其发生本附加合同约定的轻度疾病和中度疾病，则我们仅对其中一种中度疾病给付中度疾病保险金。

若被保险人在中度疾病确诊时已符合本附加合同重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、全残特别保障保险金或身故特别保障保险金的给付条件，则我们不承担给付该次及其后中度疾病保险金的保险责任。

2.轻度疾病保险金

本附加合同所承保的轻度疾病共有10种，具体疾病名称及疾病定义可于本附加合同附表三中查询。

若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因就诊并被专科医生首次确诊患有本附加合同约定的轻度疾病，则我们将给付轻度疾病保险金，其金额等于该轻度疾病确诊时本附加合同基本保险金额的30%（百分之三十）。**同一种**

轻度疾病仅给付一次，轻度疾病保险金累计给付以三次为限。当累计给付的轻度疾病保险金达到三次时，本项保险责任终止，本附加合同继续有效。

若被保险人因同一疾病或同一意外事故导致其发生本附加合同约定的两种或两种以上的轻度疾病，则我们仅对其中一种轻度疾病给付轻度疾病保险金。

若被保险人在轻度疾病确诊时已符合本附加合同重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、全残特别保障保险金或身故特别保障保险金的给付条件，则我们不承担给付该次及其后轻度疾病保险金的保险责任。

第八条　责任免除

因下列第 1 至 9 项情形之一导致被保险人发生重度疾病、中度疾病或轻度疾病的，我们不承担给付重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、中度疾病保险金或轻度疾病保险金的责任；因下列第 1 至 7 项情形之一导致被保险人身故或全残的，我们不承担给付身故特别保障保险金或全残特别保障保险金的责任：

1.投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；

2.被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施；

3.被保险人故意自伤、或自本附加合同成立或者本附加合同效力恢复之日起 2 年内自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；

4.被保险人服用、吸食或注射毒品（释义十）；

5.被保险人酒后驾驶（释义十一），无合法有效驾驶证驾驶（释义十二），或驾驶无合法有效行驶证（释义十三）的机动车（释义十四）；

6.战争（释义十五）、军事冲突（释义十六）、暴乱（释义十七）或武装叛乱；

7.核爆炸、核辐射或核污染；

8.被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病（释义十八）；

9.遗传性疾病（释义十九），先天性畸形、变形或染色体异常（释义二十）。

发生上述第 1 项情形导致被保险人身故的，本附加合同终止，我们向被保险人的继承人（除投保人本人外）退还本附加合同的现金价值。

发生上述第 1 项情形导致被保险人全残、重度疾病的，本附加合同终止，我们向被保险人退还本附加合同的现金价值。

发生上述第 2 至 7 项情形导致被保险人身故或全残的，本附加合同终止，我们向您退还本附加合同的现金价值。

第九条　其他免责条款

除本条款“第八条　责任免除”外，本附加合同中还有一些免除我们责任的条款，详见以下条款中加大加粗显示的内容：“第四条　犹豫期”、“第七条　保险责任”、“第十一条　受益人”、“第十二条　保险事故通知”、“第二十二条　效力中止与恢复”、“第二十五条　明确说明与如实告知”、“第二十六条　年龄错误的处理”、“第三十二条　释义”和本附加合同附表一、二、三中的加粗内容。

第十条　健康管理服务

我们及合作机构向被保险人提供的健康管理服务包括健康咨询和就医服务。具体内容为：

1.健康咨询：由我们及合作机构提供健康咨询、健康资讯、心理咨询和营养康复指导服务；

2.就医服务：由我们及合作机构提供就医协助服务。

上述服务的启动条件、服务内容、服务流程、服务标准、服务期限、合作机构、注意事项等服务详情参见本产品服务手册。

第十一条　受益人

您或者被保险人可以指定一人或多人为身故特别保障保险金受益人。

身故特别保障保险金受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；如果没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。

您或者被保险人可以变更身故特别保障保险金受益人并书面通知我们。我们收到变更受益人的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。

您在指定和变更身故特别保障保险金受益人时，必须经过被保险人同意。

除另有指定外，重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、中度疾病保险金、轻度疾病保险金、全残特别保障保险金的受益人为被保险人本人。

受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由我们依照关于继承的法律法规履行给付保险金的义务：

1.没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；

2.受益人先于被保险人身故，没有其他受益人的；

3.受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。

受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故先后顺序的，推定受益人身故在先。

第十二条　保险事故通知

您、被保险人或受益人知道保险事故发生后应当在 10 日内通知我们。

如果您、被保险人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，我们对无法确定的部分不承担保险责任，但我们通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响我们确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第十三条　保险金申请

申请保险金时，由相应保险金受益人作为申请人填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

1.重度疾病保险金、重度疾病特别保障保险金、中度疾病保险金、轻度疾病保险金申请所需的证明和资料

（1）保险合同；

（2）申请人及被保险人的有效身份证件；

（3）由**医院**（释义二十一）出具的病历、必需的病理检验、血液检验及其他科学诊断报告以及由专科医生出具的诊断书、手术证明；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

2.全残特别保障保险金申请所需的证明和资料

（1）保险合同；

（2）申请人及被保险人的有效身份证件；

（3）由三级医院或**鉴定机构**（释义二十二）出具的被保险人身体伤残鉴定书；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

3.身故特别保障保险金申请所需的证明和资料

（1）保险合同；

（2）申请人的有效身份证件；

（3）国家卫生行政部门认定的医疗机构、公安部门或其他相关机构出具的被保险人的死亡证明；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

保险金作为被保险人遗产时，继承人还须提供可证明其合法继承权的相关权利文件。

以上证明和资料不完整的，我们将及时一次性通知申请人补充提供。

第十四条　保险金给付

我们在收到保险金给付申请书及保险金申请所需证明和资料后，将在 5 日内作出核定；情形复杂的，在 30 日内作出核定。若我们要求投保人、被保险人或者受益人补充提供有关证明和资料的，则上述的 30 日不包括补充提供有关证明和资料的期间。

经我们核定属于保险责任的，我们在与受益人达成有关给付保险金数额的协议后 10 日内，履行给付保险金义务。

我们未及时履行前款规定义务的，将赔偿受益人因此受到的损失。前述“损失”指根据中国人民银行公布的同时期金融机构人民币活期存款基准利率计算的利息损失。

对不属于保险责任的，我们自作出核定之日起 3 日内向受益人发出拒绝给付保险金通知书，并说明理由。

我们在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起 60 日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；我们最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第十五条　宣告死亡处理

在本附加合同保险期间内，被保险人下落不明且经人民法院宣告被保险人死亡的，我们根据人民法院宣告死亡判决依法确定被保险人死亡日期，并按本条款与身故有关的约定处理。若被保险人在宣告死亡后重新出现，身故特别保障保险金受益人或继承人应于知道或应该知道被保险人重新出现后 30 日内将领取的身故特别保障保险金退还给我们。

第十六条　保险费的支付

本附加合同保险费的交费方式和**交费期间**（释义二十三）由您与我们约定并在保险单上载明。分期支付保险费的，在支付首期保险费后，您应当在每个**保险费约定支付日**（释义二十四）支付当期应交保险费。

除采取年付方式支付保险费外，若其他分期支付保险费方式情况下发生保险金给付，且本附加合同效力将根据约定终止的，则我们将扣除该**保单年度**（释义二十五）应付而未付的保险费。

第十七条　宽限期

除另有约定外，分期支付保险费的，您支付首期保险费后，如果您到期未支付保险费，自保险费约定支付日次日零时起 60 日为宽限期。宽限期内发生的保险事故，我们仍会承担保险责任，但在给付保险金时会扣减您欠交的保险费。

除另有约定外，如果您宽限期结束之时仍未支付保险费，则本附加合同自宽限期满的次日零时起效力中止。

第十八条　现金价值

指保险单所具有的价值，通常体现为解除合同时，根据精算原理计算的、由我们退还的那部分金额。保单年度末的现金价值会在保险合同上载明，保单年度内的现金价值，您可以向我们咨询。

本附加合同的现金价值金额等于基本保险金额的现金价值和累积交清增额保险金额的现金价值之和。

基本保险金额的现金价值载于保险单上，为根据保险单上的现金价值表计算而得出的金额。

累积交清增额保险金额的现金价值为根据交清增额现金价值表计算而得出的金额。

第十九条　保单贷款

经被保险人书面同意，您可申请使用保单贷款功能。

在本附加合同保险期间内且累积有现金价值的前提下，您经我们同意可以向我们申请保单贷款。累积保单贷款总金额最高不得超过本附加合同当时现金价值的 80%，且每次保单贷款期限最长为 6 个月。

我们每年宣布两次保单贷款利率（年利率），时间分别为 1 月 1 日和 7 月 1 日。

合同保单贷款的**利息**（释义二十六）按当时我们已宣布的利率计算，并沿用至该次保单贷款期满，在同一保单贷款期内，日利率按单利方式计算。保单贷款利息应在保单贷款期满之日支付，如果逾期未付，则所有利息将与原保单贷款金额，在下一保单贷款期内按其最近一次宣布的利率合并计息。当本附加合同的现金价值不足以偿还保单贷款及保单贷款利息时，本附加合同即终止。

在偿还保单贷款时，应先偿付所有保单贷款利息，然后偿还保单贷款本金。若有任何赔偿或给付，应先从该赔偿金或给付金中扣除未偿还的保单贷款及保单贷款利息。

第二十条　自动垫交

经我们同意，本附加合同的现金价值可用做自动垫交保险费。

第二十一条　减额交清

本附加合同不可变更为减额交清保险。

第二十二条　效力中止与恢复

在本附加合同效力中止期间，我们不承担保险责任。

您可以申请恢复合同效力，经您与我们协商并达成协议，自您补交保险费及其他未还款项之日起，合同效力恢复。

自本附加合同效力中止之日起满 2 年您与我们未达成协议的，我们有权解除合同。我们解除本附加合同的，向您退还合同效力中止时本附加合同的现金价值。

第二十三条　您解除合同的手续及风险

本附加合同成立后，您可以解除本附加合同，请填写解除合同通知书并向我们提供下列证明和资料：

1.保险合同；

2.您的有效身份证件。

自我们收到解除合同通知书时起，本附加合同终止。您在犹豫期后解除本附加合同的，我们自收到解除合同通知书之日起 30 日内向您退还本附加合同的现金价值。

您在犹豫期后解除合同可能会遭受一定损失。

第二十四条　附加合同效力的终止

当发生下列情形之一时，本附加合同终止：

1.在保险期间内解除本附加合同的；

2.被保险人身故的；

3.主合同终止；

4.本附加合同约定的其他终止事项。

第二十五条　明确说明与如实告知

订立本附加合同时，我们应当向您说明本附加合同的内容。对保险条款中免除我们责任的条款，我们在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不成为合同的内容。

订立本附加合同时，我们就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知。

如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保或者提高保险费率的，我们有权解除本附加合同。

如果您故意不履行如实告知义务，对于本附加合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任，并不退还保险费。

如果您因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本附加合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任，但会向您退还保险费。

第二十六条　年龄错误的处理

您在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

1.您申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本附加合同约定投保年龄限制的，我们有权解除本附加合同，并向您退还本附加合同的现金价值。对于本附加合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任；

2.您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费少于应付保险费的，我们有权更正并要求您补交保险费。如果已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付；

3.您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费多于应付保险费的，我们向您退还多收的保险费。

第二十七条　本公司合同解除权的限制

本条款第二十五、二十六条规定的合同解除权，自我们知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭。自本附加合同成立之日起超过 2 年的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们承担保险责任。

我们在合同订立时已经知道您未如实告知的情况的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们应当承担保险责任。

第二十八条　未还款项

我们在给付各项保险金、退还现金价值或者退还保险费时，如果您有欠交的保险费、保单贷款或者其他欠款，我们先扣除上述各项欠款及应付利息。

第二十九条　合同内容变更

经您与我们协商一致，可以变更本附加合同的有关内容。变更本附加合同的，应当由我们在保险合同上批注或者附贴批单，或者由您与我们订立书面的变更协议。

第三十条　联系方式变更

为了保障您的合法权益，您的住所、通讯地址、电话或电子邮件等联系方式变更时，请及时以书面形式或双方认可的其他形式通知我们。若您未以书面形式或双方认可的其他形式通知我们，我们按本附加合同载明的最后联系方式所发送的有关通知，均视为已送达给您。

第三十一条　争议处理

本附加合同争议的解决方式，由当事人在保险合同中约定从下列两种方式中选择一种：

1.因履行本附加合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，由双方达成仲裁协议通过仲裁解决；

2.因履行本附加合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

第三十二条　释义

释义一.周岁：指按有效身份证件中记载的出生日期计算的年龄，自出生之日起为0周岁，每经过一年增加一岁，不足一年的不计。

释义二.有效身份证件：指由中华人民共和国政府主管部门规定的能够证明其身份的证件，如：有效期内的居民身份证、港澳台居民居住证、户口簿以及中华人民共和国政府主管部门颁发或者认可的有效护照或者其他身份证明文件。

释义三.重度疾病：指符合本附加合同附表一定义的40种疾病、疾病状态或手术。

释义四.中度疾病：指符合本附加合同附表二定义的5种疾病、疾病状态或手术。

释义五.轻度疾病：指符合本附加合同附表三定义的10种疾病、疾病状态或手术。

释义六.意外事故：指外来的、突发的、不可预见的、非本意的和非疾病的导致被保险人身体受到伤害的客观事件。

释义七.专科医生：

专科医生应当同时满足以下四项资格条件：

（1）具有有效的中华人民共和国《医师资格证书》；

（2）具有有效的中华人民共和国《医师执业证书》，并按期到相关部门登记注册；

（3）具有有效的中华人民共和国主治医师或主治医师以上职称的《医师职称证书》；

（4）在国家《医院分级管理标准》二级或二级以上医院的相应科室从事临床工作三年以上。

释义八.保单周年日：指保险合同生效日在合同生效后每年的对应日，不含合同生效日当日。如果当月没有对应的同一日，则以该月最后一日为对应日。

释义九.全残：指被保险人在本附加合同保险期间内，发生下列情况之一者，

1.双目永久完全失明的（注1）；

2.两上肢腕关节以上或两下肢踝关节以上缺失的；

3.一上肢腕关节以上及一下肢踝关节以上缺失的；

4.一目永久完全失明及一上肢腕关节以上缺失的；

5.一目永久完全失明及一下肢踝关节以上缺失的；

6.四肢关节机能永久完全丧失的（注2）；

7.咀嚼、吞咽机能永久完全丧失的（注3）；

8.中枢神经系统机能或胸、腹部脏器机能极度障碍，终身不能从事任何工作，为维持生命必要的日常生活活动，全需他人扶助的（注4）。

注：（1）失明包括眼球缺失或摘除、或不能辨别明暗、或仅能辨别眼前手动者。最佳矫正视力低于国际标准视力表0.02，或视野半径小于5度，并由有资格的眼科医师出具医疗诊断证明。

（2）关节机能的丧失系指关节永久完全僵硬、或麻痹、或关节不能随意识活动。

（3）咀嚼、吞咽机能的丧失系指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍，以致不能作咀嚼、吞咽运动，除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。

（4）为维持生命必要之日常生活活动，全需他人扶助系指食物摄取、大小便始末、穿脱衣服、起居、步行、入浴等，皆不能自理，需要他人帮助。

所谓永久完全系指自以上情况发生之日起经过 180 天的治疗，机能仍然完全丧失，但眼球摘除等明显无法复原之情况，不在此限。

释义十.毒品：指《中华人民共和国刑法》规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

释义十一.酒后驾驶：指经检测或鉴定，发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准，公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》或道路交通相关法规的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。

释义十二.无合法有效驾驶证驾驶：指下列情形之一：

1.没有取得中华人民共和国有关主管部门颁发或者认可的驾驶资格证书；

2.驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；

3.持审验不合格的驾驶证驾驶；

4.持学习驾驶证学习驾车时，无教练员随车指导，或不按指定时间、路线学习驾车。

释义十三.无合法有效行驶证：指下列情形之一：

1.机动车被依法注销登记的；

2.未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

释义十四.机动车：指以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆或履带车辆。

释义十五.战争：指国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间为了一定的政治、经济目的而进行的武装斗争，以政府宣布为准。

释义十六.军事冲突：指国家或民族之间在一定范围内的武装对抗，以政府宣布为准。

释义十七.暴乱：指破坏社会秩序的武装骚动，以政府宣布为准。

释义十八.感染艾滋病病毒或患艾滋病

艾滋病病毒指人类免疫缺陷病毒，英文缩写为 HIV。艾滋病指人类免疫缺陷病毒引起的获得性免疫缺陷综合征，英文缩写为 AIDS。

在人体血液或其他样本中检测到艾滋病病毒或其抗体呈阳性，没有出现临床症状或体征的，为感染艾滋病病毒；如果同时出现了明显临床症状或体征的，为患艾滋病。

释义十九.遗传性疾病：指生殖细胞或受精卵的遗传物质（染色体和基因）发生突变或畸变所引起的疾病，通常具有由亲代传至后代的垂直传递的特征。

释义二十.先天性畸形、变形或染色体异常：指被保险人出生时就具有的畸形、变形或染色体异常。先天性畸形、变形和染色体异常依照世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）确定。

释义二十一.医院：指符合下列所有条件的机构，

（1）拥有合法经营执照；

（2）设立的主要目的为向受伤者和患病者提供留院治疗和护理服务；

（3）有合格的医生和护士提供全日二十四小时的医疗和护理服务。

作为康复医院、诊所、护理、疗养、戒酒、戒毒或类似的医疗机构均不属于本附加合同的医院范围。

释义二十二.鉴定机构：指司法部或省级司法行政机关审核登记、从事司法鉴定业务的法人或者其他组织。

释义二十三.交费期间：指从保险合同生效日起至保险合同的最后一个保险费约定支付日后的下一个保单周年日 24 时止的期间。若最后一个保险费约定支付日发生变更，则以变更后的保险费约定支付日计算交费期间。

释义二十四.保险费约定支付日：指保险合同生效日在每月、每季、每半年或每年（根据交费方式确定）的对应日。如果当月无对应的同一日，则以该月最后一日为对应日。

释义二十五.保单年度：指从保险合同生效日或保单周年日当日 24 时起至下一年度保险合同保单周年日当日 24 时止的期间为一个保单年度。

释义二十六.利息：除本附加合同“保险金给付”条款外，本附加合同其他条款所指的利息均按保单贷款利率计算。

释义二十七.组织病理学检查

组织病理学检查是通过局部切除、钳取、穿刺等手术方法，从患者机体采取病变组织块，经过包埋、切片后，进行病理检查的方法。

通过采集病变部位脱落细胞、细针吸取病变部位细胞、体腔积液分离病变细胞等方式获取病变细胞，制成涂片，进行病理检查的方法，属于细胞病理学检查，不属于组织病理学检查。

释义二十八.ICD-10 与ICD-O-3

《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10），是世界卫生组织（WHO）发布的国际通用的疾病分类方法。《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版（ICD-O-3），是WHO发布的针对ICD中肿瘤形态学组织学细胞类型、动态、分化程度的补充编码。其中形态学编码：0 代表良性肿瘤；1 代表动态未定性肿瘤；2 代表原位癌和非侵袭性癌；3 代表恶性肿瘤（原发性）；6 代表恶性肿瘤（转移性）；9 代表恶性肿瘤（原发性或转移性未肯定）。如果出现ICD-10 与ICD-O-3 不一致的情况，以ICD-O-3 为准。

释义二十九.TNM分期

TNM分期采用AJCC癌症分期手册标准。该标准由美国癌症联合委员会与国际抗癌联合会TNM委员会联合制定，是目前肿瘤医学分期的国际通用标准。T指原发肿瘤的大小、形态等；N指淋巴结的转移情况；M指有无其他脏器的转移情况。

释义三十.甲状腺癌的 TNM 分期

甲状腺癌的 TNM 分期采用目前现行的 AJCC 第八版定义标准，我国国家卫生健康委员会2018年发布的《甲状腺癌诊疗规范（2018年版）》也采用此定义标准，具体见下：

甲状腺乳头状癌、滤泡癌、低分化癌、Hürthle 细胞癌和未分化癌

pT_X：原发肿瘤不能评估

pT_0：无肿瘤证据

pT_1：肿瘤局限在甲状腺内，最大径≤2cm

T_{1a}肿瘤最大径≤1cm

T_{1b}肿瘤最大径＞1cm，≤2cm

pT_2：肿瘤2～4cm

pT_3：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内或大体侵犯甲状腺外带状肌

pT_{3a}：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内

pT_{3b}：大体侵犯甲状腺外带状肌，无论肿瘤大小

带状肌包括：胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌

pT_4：大体侵犯甲状腺外带状肌外

pT_{4a}：侵犯喉、气管、食管、喉反神经及皮下软组织

pT_{4b}：侵犯椎前筋膜，或包裹颈动脉、纵隔血管

甲状腺髓样癌

pT_X：原发肿瘤不能评估

pT_0：无肿瘤证据

pT_1：肿瘤局限在甲状腺内，最大径≤2cm

T_{1a}肿瘤最大径≤1cm

T_{1b}肿瘤最大径＞1cm，≤2cm

pT_2：肿瘤2～4cm

pT_3：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内或大体侵犯甲状腺外带状肌

pT_{3a}：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内

pT_{3b}：大体侵犯甲状腺外带状肌，无论肿瘤大小

带状肌包括：胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌

pT_4：进展期病变

pT_{4a}：中度进展，任何大小的肿瘤，侵犯甲状腺外颈部周围器官和软组织，如喉、气管、食管、喉反神经及皮下软组织

pT_{4b}：重度进展，任何大小的肿瘤，侵犯椎前筋膜，或包裹颈动脉、纵隔血管

区域淋巴结：适用于所有甲状腺癌

pN_x：区域淋巴结无法评估

pN_0：无淋巴结转移证据

pN_1：区域淋巴结转移

pN_{1a}：转移至Ⅵ、Ⅶ区（包括气管旁、气管前、喉前/Delphian 或上纵隔）淋巴结，可以为单侧或双侧。

pN_{1b}：单侧、双侧或对侧颈淋巴结转移（包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ或Ⅴ区）淋巴结或咽后淋巴结转移。

远处转移：适用于所有甲状腺癌

M_0：无远处转移

M_1：有远处转移

乳头状或滤泡状癌（分化型）

年龄＜55 岁			
	T	N	M
Ⅰ期	任何	任何	0
Ⅱ期	任何	任何	1
年龄≥55 岁			
Ⅰ期	1	0/x	0
	2	0/x	0
Ⅱ期	1～2	1	0
	3a～3b	任何	0
Ⅲ期	4a	任何	0
ⅣA 期	4b	任何	0
ⅣB 期	任何	任何	1
髓样癌（所有年龄组）			
Ⅰ期	1	0	0
Ⅱ期	2～3	0	0
Ⅲ期	1～3	1a	0
ⅣA 期	4a	任何	0
	1～3	1b	0
ⅣB 期	4b	任何	0
ⅣC 期	任何	任何	1
未分化癌（所有年龄组）			
ⅣA 期	1～3a	0/x	0
ⅣB 期	1～3a	1	0
	3b～4	任何	0
ⅣC 期	任何	任何	1

注：以上表格中“年龄”指患者病理组织标本获取日期时的年龄。

释义三十一.肢体：指包括肩关节的整个上肢或包括髋关节的整个下肢。

释义三十二.肌力：指肌肉收缩时的力量。肌力划分为 0-5 级，具体为：

0 级：肌肉完全瘫痪，毫无收缩。

1 级：可看到或者触及肌肉轻微收缩，但不能产生动作。

2 级：肌肉在不受重力影响下，可进行运动，即肢体能在床面上移动，但不能抬高。

3 级：在和地心引力相反的方向中尚能完成其动作，但不能对抗外加阻力。

4 级：能对抗一定的阻力，但较正常人为低。

5 级：正常肌力。

释义三十三.语言能力完全丧失，或严重咀嚼吞咽功能障碍

语言能力完全丧失，指无法发出四种语音（包括口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音）中的任何三种、或声带全部切除，或因大脑语言中枢受伤害而患失语症。

严重咀嚼吞咽功能障碍，指因牙齿以外的原因导致器质障碍或机能障碍，以致不能作咀嚼吞咽运动，除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。

释义三十四.六项基本日常生活活动，指：

（1）穿衣：自己能够穿衣及脱衣；

（2）移动：自己从一个房间到另一个房间；

（3）行动：自己上下床或上下轮椅；

（4）如厕：自己控制进行大小便；

（5）进食：自己从已准备好的碗或碟中取食物放入口中；

（6）洗澡：自己进行淋浴或盆浴。

六项基本日常生活活动能力的鉴定不适用于0-3周岁幼儿。

释义三十五.永久不可逆：指自疾病确诊或意外伤害发生之日起，经过积极治疗180天后，仍无法通过现有医疗手段恢复。

释义三十六.美国纽约心脏病学会（New York Heart Association，NYHA）心功能状态分级

美国纽约心脏病学会（New York Heart Association，NYHA）将心功能状态分为四级：

Ⅰ级：心脏病病人日常活动量不受限制，一般活动不引起乏力、呼吸困难等心衰症状。

Ⅱ级：心脏病病人体力活动轻度受限制，休息时无自觉症状，一般活动下可出现心衰症状。

Ⅲ级：心脏病病人体力活动明显受限，低于平时一般活动即引起心衰症状。

Ⅳ级：心脏病病人不能从事任何体力活动，休息状态下也存在心衰症状，活动后加重。

附表一：重度疾病列表及定义

重度疾病（40 种）	
恶性肿瘤——重度（疾病定义一.1）	较重急性心肌梗死（疾病定义一.2）
严重脑中风后遗症（疾病定义一.3）	重大器官移植术或造血干细胞移植术（疾病定义一.4）
冠状动脉搭桥术（或称冠状动脉旁路移植术）（疾病定义一.5）	严重慢性肾衰竭（疾病定义一.6）
多个肢体缺失（疾病定义一.7）	急性重症肝炎或亚急性重症肝炎（疾病定义一.8）
严重非恶性颅内肿瘤（疾病定义一.9）	严重慢性肝衰竭（疾病定义一.10）
严重脑炎后遗症或严重脑膜炎后遗症（疾病定义一.11）	深度昏迷（疾病定义一.12）
双耳失聪（疾病定义一.13）	双目失明（疾病定义一.14）
瘫痪（疾病定义一.15）	心脏瓣膜手术（疾病定义一.16）
严重阿尔茨海默病（疾病定义一.17）	严重脑损伤（疾病定义一.18）
严重原发性帕金森病（疾病定义一.19）	严重III度烧伤（疾病定义一.20）
严重特发性肺动脉高压（疾病定义一.21）	严重运动神经元病（疾病定义一.22）
语言能力丧失（疾病定义一.23）	重型再生障碍性贫血（疾病定义一.24）
主动脉手术（疾病定义一.25）	严重慢性呼吸衰竭（疾病定义一.26）
严重克罗恩病（疾病定义一.27）	严重溃疡性结肠炎（疾病定义一.28）
严重急性坏死性胰腺炎（疾病定义一.29）	弥漫性血管内凝血（疾病定义一.30）
败血症导致的多器官功能障碍综合症（疾病定义一.31）	严重心肌炎（疾病定义一.32）
感染性心内膜炎（疾病定义一.33）	风湿热导致的心脏瓣膜疾病（疾病定义一.34）
进行性多灶性白质脑病（疾病定义一.35）	重症急性坏死性筋膜炎（疾病定义一.36）
多处臂丛神经根性撕脱（疾病定义一.37）	溶血性链球菌性坏疽（疾病定义一.38）
严重面部烧伤（疾病定义一.39）	严重气性坏疽（疾病定义一.40）

疾病定义一：

重度疾病：指符合以下定义的 40 种疾病、疾病状态或手术。

1）恶性肿瘤——重度

指恶性细胞不受控制的进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位，病灶经**组织病理学检查**（释义二十七）（涵盖骨髓病理学检查）结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织（WHO，World Health Organization）《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版**（ICD-10）**（释义二十八）的恶性肿瘤类别及《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版**（ICD-O-3）**（释义二十八）的肿瘤形态学编码属于 3、6、9（恶性肿瘤）范畴的疾病。

下列疾病不属于“恶性肿瘤——重度”，不在保障范围内：

（1）ICD-O-3 肿瘤形态学编码属于 0（良性肿瘤）、1（动态未定性肿瘤）、2（原位癌和非侵袭性癌）范畴的疾病，如：

a.原位癌，癌前病变，非浸润性癌，非侵袭性癌，肿瘤细胞未侵犯基底层，上皮内瘤变，细胞不典型性增生等；

b.交界性肿瘤，交界恶性肿瘤，肿瘤低度恶性潜能，潜在低度恶性肿瘤等；

（2）TNM 分期（释义二十九）为Ⅰ期或更轻分期的甲状腺癌（释义三十）；

（3）TNM 分期为 $T_1N_0M_0$ 期或更轻分期的前列腺癌；

（4）黑色素瘤以外的未发生淋巴结和远处转移的皮肤恶性肿瘤；

（5）相当于 Binet 分期方案 A 期程度的慢性淋巴细胞白血病；

（6）相当于 Ann Arbor 分期方案Ⅰ期程度的何杰金氏病；

（7）未发生淋巴结和远处转移且 WHO 分级为 G1 级别（核分裂像<10/50 HPF 和 ki-67≤2%）或更轻分级的神经内分泌肿瘤。

2）较重急性心肌梗死

急性心肌梗死指由于冠状动脉闭塞或梗阻引起部分心肌严重的持久性缺血造成急性心肌坏死。急性心肌梗死的诊断必须依据国际国内诊断标准，符合（1）检测到肌酸激酶同工酶（CK-MB）或肌钙蛋白（cTn）升高和/或降低的动态变化，至少一次达到或超过心肌梗死的临床诊断标准；（2）同时存在下列之一的证据，包括：缺血性胸痛症状、新发生的缺血性心电图改变、新生成的病理性 Q 波、影像学证据显示有新出现的心肌活性丧失或新出现局部室壁运动异常、冠脉造影证实存在冠状动脉血栓。

较重急性心肌梗死指依照上述标准被明确诊断为急性心肌梗死，并且必须同时满足下列至少一项条件：

（1）心肌损伤标志物肌钙蛋白（cTn）升高，至少一次检测结果达到该检验正常参考值上限的 15 倍（含）以上；

（2）肌酸激酶同工酶（CK-MB）升高，至少一次检测结果达到该检验正常参考值上限的 2 倍（含）以上；

（3）出现左心室收缩功能下降，在确诊 6 周以后，检测左室射血分数（LVEF）低于 50%（不含）；

（4）影像学检查证实存在新发的乳头肌功能失调或断裂引起的中度（含）以上的二尖瓣反流；

（5）影像学检查证实存在新出现的室壁瘤；

（6）出现室性心动过速、心室颤动或心源性休克。

其他非冠状动脉阻塞性疾病所引起的肌钙蛋白（cTn）升高不在保障范围内。

3）严重脑中风后遗症

指因脑血管的突发病变引起脑血管出血、栓塞或梗塞，须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）等影像学检查证实，并导致神经系统永久性的功能障碍。神经系统永久性的功能障碍，指疾病确诊 180 天后，仍遗留下列至少一种障碍：

（1）一肢（含）以上**肢体**（释义三十一）**肌力**（释义三十二）2 级（含）以下；

（2）**语言能力完全丧失，或严重咀嚼吞咽功能障碍**（释义三十三）；

（3）自主生活能力完全丧失，无法独立完成**六项基本日常生活活动**（释义三十四）中的三项或三项以上。

4）重大器官移植术或造血干细胞移植术

重大器官移植术，指因相应器官功能衰竭，已经实施了肾脏、肝脏、心脏、肺脏或小肠的异体移植手术。

造血干细胞移植术，指因造血功能损害或造血系统恶性肿瘤，已经实施了造血干细胞（包括骨髓造血干细胞、外周血造血干细胞和脐血造血干细胞）的移植手术。

5）冠状动脉搭桥术（或称冠状动脉旁路移植术）

指为治疗严重的冠心病，已经实施了切开心包进行的冠状动脉血管旁路移植的手术。

所有未切开心包的冠状动脉介入治疗不在保障范围内。

6）严重慢性肾衰竭

指双肾功能慢性不可逆性衰竭，依据肾脏病预后质量倡议（K/DOQI）制定的指南，分期达到慢性肾脏病 5 期，且经诊断后已经进行了至少 90 天的规律性透析治疗。规律性透析是指每周进行血液透析或每天进行腹膜透析。

7）多个肢体缺失

指因疾病或意外伤害导致两个或两个以上肢体自腕关节或踝关节近端（靠近躯干端）以上完全性断离。

8）急性重症肝炎或亚急性重症肝炎

指因肝炎病毒感染引起肝脏组织弥漫性坏死，导致急性肝功能衰竭，且经血清学或病毒学检查证实，并须满足下列全部条件：

（1）重度黄疸或黄疸迅速加重；

（2）肝性脑病；

（3）B 超或其他影像学检查显示肝脏体积急速萎缩；

（4）肝功能指标进行性恶化。

9）严重非恶性颅内肿瘤

指起源于脑、脑神经、脑被膜的非恶性肿瘤，ICD-O-3 肿瘤形态学编码属于 0（良性肿瘤）、1（动态未定性肿瘤）范畴，并已经引起颅内压升高或神经系统功能损害，出现视乳头水肿或视觉受损、听觉受损、面部或肢体瘫痪、癫痫等，须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）或正电子发射断层扫描（PET）等影像学检查证实，且须满足下列至少一项条件：

（1）已经实施了开颅进行的颅内肿瘤完全或部分切除手术；

（2）已经实施了针对颅内肿瘤的放射治疗，如γ刀、质子重离子治疗等。

下列疾病不在保障范围内：

（1）脑垂体瘤；

（2）脑囊肿；

（3）颅内血管性疾病（如脑动脉瘤、脑动静脉畸形、海绵状血管瘤、毛细血管扩张症等）。

10）严重慢性肝衰竭

指因慢性肝脏疾病导致的肝衰竭，且须满足下列全部条件：

（1）持续性黄疸；

（2）腹水；

（3）肝性脑病；

（4）充血性脾肿大伴脾功能亢进或食管胃底静脉曲张。

因酗酒或药物滥用导致的肝衰竭不在保障范围内。

11）严重脑炎后遗症或严重脑膜炎后遗症

指因患脑炎或脑膜炎导致的神经系统永久性的功能障碍。神经系统永久性的功能障碍，指经相关专科医生确诊疾病 180 天后，仍遗留下列至少一种障碍：

（1）一肢（含）以上肢体肌力 2 级（含）以下；

（2）语言能力完全丧失，或严重咀嚼吞咽功能障碍；

（3）由具有评估资格的专科医生根据临床痴呆评定量表（CDR，Clinical Dementia Rating）评估结果为 3 分；

（4）自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上。

12）深度昏迷

指因疾病或意外伤害导致意识丧失，对外界刺激和体内需求均无反应，昏迷程度按照格拉斯哥昏迷分级（GCS，Glasgow Coma Scale）结果为 5 分或 5 分以下，且已经持续使用呼吸机及其他生命维持系统 96 小时以上。

因酗酒或药物滥用导致的深度昏迷不在保障范围内。

13）双耳失聪

指因疾病或意外伤害导致双耳听力**永久不可逆**（释义三十五）性丧失，在 500 赫兹、1000 赫兹和 2000 赫兹语音频率下，平均听阈大于等于 91 分贝，且经纯音听力测试、声导抗检测或听觉诱发电位检测等证实。

被保险人申请理赔时年龄必须在三周岁以上，并且提供理赔当时的听力丧失诊断及检查证明和资料。

14）双目失明

指因疾病或意外伤害导致双眼视力永久不可逆性丧失，双眼中较好眼须满足下列至少一项条件：

（1）眼球缺失或摘除；

（2）矫正视力低于 0.02（采用国际标准视力表，如果使用其他视力表应进行换算）；

（3）视野半径小于 5 度。

被保险人申请理赔时年龄必须在三周岁以上，并且提供理赔当时的视力丧失诊断及检查证明和资料。

15）瘫痪

指因疾病或意外伤害导致两肢或两肢以上肢体随意运动功能永久完全丧失。肢体随意运动功能永久完全丧失，指疾病确诊 180 天后或意外伤害发生 180 天后，每肢三大关节中的两大关节仍然完全僵硬，或肢体肌力在 2 级（含）以下。

16）心脏瓣膜手术

指为治疗心脏瓣膜疾病，已经实施了切开心脏进行的心脏瓣膜置换或修复的手术。

所有未切开心脏的心脏瓣膜介入手术不在保障范围内。

17）严重阿尔茨海默病

指因大脑进行性、不可逆性改变导致智能严重衰退或丧失，临床表现为严重的认知功能障碍、精神行为异常和社交能力减退等，其日常生活必须持续受到他人监护。须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）或正电子发射断层扫描（PET）等影像学检查证实，并经相关专科医生确诊，且须满足下列至少一项条件：

（1）由具有评估资格的专科医生根据临床痴呆评定量表（CDR，Clinical Dementia Rating）评估结果为 3 分；

（2）自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上。

阿尔茨海默病之外的其他类型痴呆不在保障范围内。

18）严重脑损伤

指因头部遭受机械性外力，引起脑重要部位损伤，导致神经系统永久性的功能障碍。须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）或正电子发射断层扫描（PET）等影像学检查证实。神经系统永久性的功能障碍，指脑损伤 180 天后，仍遗留下列至少一种障碍：

（1）一肢（含）以上肢体肌力 2 级（含）以下；

（2）语言能力完全丧失，或严重咀嚼吞咽功能障碍；

（3）自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上。

19）严重原发性帕金森病

是一种中枢神经系统的退行性疾病，临床表现为运动迟缓、静止性震颤或肌强直等，经相关专科医生确诊，且须满足自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上。

继发性帕金森综合征、帕金森叠加综合征不在保障范围内。

20）严重Ⅲ度烧伤

指烧伤程度为Ⅲ度，且Ⅲ度烧伤的面积达到全身体表面积的 20%或 20%以上。体表面积根据《中国新九分法》计算。

21）严重特发性肺动脉高压

指不明原因的肺动脉压力持续性增高，进行性发展而导致的慢性疾病，已经造成永久不可逆性的体力活动能力受限，达到**美国纽约心脏病学会（New York Heart Association，NYHA）心功能状态分级**（释义三十六）Ⅳ级，且静息状态下肺动脉平均压在 36mmHg（含）以上。

22）严重运动神经元病

是一组中枢神经系统运动神经元的进行性变性疾病，包括进行性脊肌萎缩症、进行性延髓麻痹症、原发性侧索硬化症、肌萎缩性侧索硬化症，经相关专科医生确诊，且须满足下列至少一项条件：

（1）严重咀嚼吞咽功能障碍；

（2）呼吸肌麻痹导致严重呼吸困难，且已经持续使用呼吸机 7 天（含）以上；

（3）自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上。

23）语言能力丧失

指因疾病或意外伤害导致语言能力完全丧失，经过积极治疗至少 12 个月（声带完全切除不受此时间限制），仍无法通过现有医疗手段恢复。

精神心理因素所致的语言能力丧失不在保障范围内。

被保险人申请理赔时年龄必须在三周岁以上，并且提供理赔当时的语言能力丧失诊断及检查证明和资料。

24）重型再生障碍性贫血

指因骨髓造血功能慢性持续性衰竭导致的贫血、中性粒细胞减少及血小板减少，且须满足下列全部条件：

（1）骨髓穿刺检查或骨髓活检结果支持诊断：骨髓细胞增生程度<正常的 25%；如≥正常的 25%但<50%，则残存的造血细胞应<30%；

（2）外周血象须具备以下三项条件中的两项：

①中性粒细胞绝对值$<0.5\times10^9$/L；

②网织红细胞计数$<20\times10^9$/L；

③血小板绝对值$<20\times10^9$/L。

25）主动脉手术

指为治疗主动脉疾病或主动脉创伤，已经实施了开胸（含胸腔镜下）或开腹（含腹腔镜下）进行的切除、置换、修补病损主动脉血管、主动脉创伤后修复的手术。主动脉指升主动脉、主动脉弓和降主动脉（含胸主动脉和腹主动脉），**不包括升主动脉、主动脉弓和降主动脉的分支血管。**

所有未实施开胸或开腹的动脉内介入治疗不在保障范围内。

26）严重慢性呼吸衰竭

指因慢性呼吸系统疾病导致永久不可逆性的呼吸衰竭，经过积极治疗 180 天后满足以下所有条件：

（1）静息时出现呼吸困难；

（2）肺功能第一秒用力呼气容积（FEV_1）占预计值的百分比＜30%；

（3）在静息状态、呼吸空气条件下，动脉血氧分压（PaO_2）＜50mmHg。

27）严重克罗恩病

指一种慢性肉芽肿性肠炎，具有特征性的克罗恩病（Crohn 病）病理组织学变化，须根据组织病理学特点诊断，且已经造成瘘管形成并伴有肠梗阻或肠穿孔。

28）严重溃疡性结肠炎

指伴有致命性电解质紊乱的急性暴发性溃疡性结肠炎，病变已经累及全结肠，表现为严重的血便和系统性症状体征，须根据组织病理学特点诊断，且已经实施了结肠切除或回肠造瘘术。

上述二十八种重度疾病依照中国保险行业协会制定的《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020 年修订版）》标准定义，其他重度疾病依照本附加合同约定定义。

29）严重急性坏死性胰腺炎

指由专科医生确诊为急性坏死性胰腺炎，并进行坏死组织清除、病灶切除或胰腺部分切除的手术治疗。

因酒精导致的急性坏死性胰腺炎不在保障范围内。

30）弥漫性血管内凝血

指血液凝固系统和纤溶系统的过度活动导致微血管血栓形成、血小板及凝血因子耗竭和严重出血，需要输注血浆和浓缩血小板进行治疗。须提供同时具有下列条件中的至少三项的检验报告：

（1）血小板计数<100×10^9/L 或者呈进行性下降；

（2）血浆纤维蛋白原含量<1.5g/L 或者>4g/L 或者呈进行性下降；

（3）3P 试验阳性或者血浆 FDP>20mg/L；

（4）凝血酶原时间>15 秒或者超过对照组 3 秒以上。

31）败血症导致的多器官功能障碍综合症

指败血症导致的一个或多个器官系统生理功能障碍，因该疾病住院至少 96 小时，并须满足下列条件之一：

（1）呼吸衰竭，需要进行气管插管机械通气；

（2）凝血血小板计数<50×10^3/μL；

（3）肝功能不全，胆红素>6mg/dl 或>102μmol/L；

（4）已经应用强心剂；

（5）昏迷程度按照格拉斯哥昏迷分级（GCS，Glasgow Coma Scale）结果为 9 分或 9 分以下；

（6）肾功能衰竭，血清肌酐>300μmol/L 或>3.5mg/dl 或尿量<500ml/d；

（7）败血症有血液检查证实。

败血症引起的多器官功能障碍综合症的诊断应由专科医生证实。**非败血症引起的多器官功能障碍综合症不在保障范围内。**

32）严重心肌炎

指心肌的严重感染而导致至少持续 180 天的心功能损害。心功能损害必须满足下列全部条件：

（1）左室腔扩大至少达到正常值上限的 120%；

（2）左室射血分数持续性低于 40%。

33）感染性心内膜炎

指由感染性微生物引致的心脏内膜炎症，须符合下列所有标准：

（1）血液培养结果呈阳性反应，证明感染性微生物的存在；

（2）心内膜炎引起中度心瓣膜关闭不全（指返流指数 20%或以上）或中度心瓣膜狭窄（指心瓣膜开口范围小于或等于正常值的 30%）。

34）风湿热导致的心脏瓣膜疾病

指根据已修订的 Jones 标准诊断证实罹患急性风湿热，且经心脏超声检查证实因风湿热所导致至少一个心脏瓣膜关闭不全（即返流部分达 20%或以上）或狭窄的心瓣膜损伤（指心瓣膜开口范围小于或等于正常值的 30%）。

35）进行性多灶性白质脑病

是一种亚急性脱髓鞘性脑病，常常发生于免疫缺陷的病人。须经脑组织活检确诊。

36）重症急性坏死性筋膜炎

指一种由细菌侵入皮下组织和筋膜引起的急性坏死性软组织感染，可伴有毒血症、败血症、中毒性休克、弥漫性血管内凝血及多器官衰竭。必须满足下列全部条件：

（1）细菌培养和临床表现符合坏死性筋膜炎诊断标准；

（2）病情迅速恶化，有脓毒血症表现；

（3）受感染肢体被截肢（自腕关节或踝关节近端）。

37）多处臂丛神经根性撕脱

由于疾病或意外伤害导致至少两根臂丛神经根性撕脱，造成永久不可逆的手臂感觉功能与运动功能完全丧失。须有电生理检查结果证实。

38）溶血性链球菌性坏疽

指包围肢体或躯干的浅筋膜或深筋膜受到溶血性链球菌的感染，病情在短时间内急剧恶化，须病原学诊断明确，且已经实施了手术及清创术治疗。

39）严重面部烧伤

指面部烧伤程度为III度，且面部III度烧伤的面积达到面部表面积的 80%或以上。

40）严重气性坏疽

指由梭状芽胞杆菌所致的肌坏死或肌炎。须经专科医生明确诊断，且须同时符合下列条件：

（1）符合气性坏疽的一般临床表现；

（2）细菌培养检出致病菌；

（3）出现广泛性肌肉及组织坏死，并已经实施了坏死组织和筋膜以及肌肉的切除手术。**清创术不在保障范围内。**

附表二：中度疾病列表及定义

中度疾病（5 种）	
中度运动神经元病（疾病定义二.1）	中度阿尔茨海默病（疾病定义二.2）
中度脑损伤（疾病定义二.3）	中度原发性帕金森病（疾病定义二.4）
中度脑炎后遗症或中度脑膜炎后遗症（疾病定义二.5）	

疾病定义二：

中度疾病：指符合以下定义的 5 种疾病、疾病状态或手术。

1）中度运动神经元病

是一组中枢神经系统运动神经元的进行性变性疾病，包括进行性脊肌萎缩症、进行性延髓麻痹症、原发性侧索硬化症、肌萎缩性侧索硬化症，经相关专科医生确诊，且须满足自主生活能力部分丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项，但未达到重度疾病“严重运动神经元病”的给付标准。

2）中度阿尔茨海默病

阿尔茨海默病指因大脑进行性、不可逆性改变导致智能严重衰退或丧失，临床表现为明显的认知能力障碍、行为异常和社交能力减退，其日常生活必须持续受到他人监护。本附加合同所保障的“中度阿尔茨海默病”须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）或正电子发射断层扫描（PET）等影像学检查证实，并经相关专科医生确诊，且自主生活能力部分丧失，至少 180 天无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项，但未达到重度疾病“严重阿尔茨海默病”的给付标准。

阿尔茨海默病之外的其他类型痴呆不在保障范围内。

3）中度脑损伤

脑损伤指因头部遭受机械性外力，引起脑重要部位损伤，导致神经系统永久性的功能障碍。本附加合同所保障的“中度脑损伤”须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）或正电子发射断层扫描（PET）等影像学检查证实，并在脑损伤 180 天后，仍遗留下列至少一种障碍，但未达到重度疾病“严重脑损伤”的给付标准。

（1）一肢（含）以上肢体肌力为 3 级；

（2）自主生活能力部分丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项。

4）中度原发性帕金森病

是一种中枢神经系统的退行性疾病，临床表现为运动迟缓、静止性震颤或肌强直等，经相关专科医生确诊，且须满足确诊 180 天后自主生活能力仍部分丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项，但未达到重度疾病“严重原发性帕金森病”的给付标准。

继发性帕金森综合征、帕金森叠加综合征不在保障范围内。

5）中度脑炎后遗症或中度脑膜炎后遗症

脑炎后遗症或脑膜炎后遗症指因患脑炎或脑膜炎导致的神经系统永久性的功能障碍。本附加合同所保障的“中度脑炎或脑膜炎后遗症”指经相关专科医生确诊疾病 180 天后，仍遗留下列至少一种障碍，但未达到重度疾病“严重脑炎后遗症或严重脑膜炎后遗症”的给付标准：

（1）一肢（含）以上肢体肌力为 3 级；

（2）自主生活能力部分丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项。

附表三：轻度疾病列表及定义

轻度疾病（10 种）	
恶性肿瘤——轻度（疾病定义三.1）	较轻急性心肌梗死（疾病定义三.2）
轻度脑中风后遗症（疾病定义三.3）	较小面积Ⅲ度烧伤（疾病定义三.4）
深度昏迷 48 小时（疾病定义三.5）	轻度面部烧伤（疾病定义三.6）
轻度再生障碍性贫血（疾病定义三.7）	急性肾功能衰竭肾脏透析治疗（疾病定义三.8）
外伤性全脾切除手术（疾病定义三.9）	轻度坏死性筋膜炎（疾病定义三.10）

疾病定义三：

轻度疾病：指符合以下定义的 10 种疾病、疾病状态或手术。

1）恶性肿瘤——轻度

指恶性细胞不受控制的进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位，病灶经组织病理学检查（涵盖骨髓病理学检查）结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织（WHO，World Health Organization）《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）的恶性肿瘤类别及《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版（ICD-O-3）的肿瘤形态学编码属于 3、6、9（恶性肿瘤）范畴，但不在“恶性肿瘤——重度”保障范围的疾病。且特指下列六项之一：

（1）TNM 分期为Ⅰ期的甲状腺癌；

（2）TNM 分期为 $T_1N_0M_0$ 期的前列腺癌；

（3）黑色素瘤以外的未发生淋巴结和远处转移的皮肤恶性肿瘤；

（4）相当于 Binet 分期方案 A 期程度的慢性淋巴细胞白血病；

（5）相当于 Ann Arbor 分期方案Ⅰ期程度的何杰金氏病；

（6）未发生淋巴结和远处转移且 WHO 分级为 G1 级别（核分裂像<10/50 HPF 和 ki-67≤2%）的神经内分泌肿瘤。

下列疾病不属于“恶性肿瘤——轻度”，不在保障范围内：

ICD-O-3 肿瘤形态学编码属于 0（良性肿瘤）、1（动态未定性肿瘤）、2（原位癌和非侵袭性癌）范畴的疾病，如：

a.原位癌，癌前病变，非浸润性癌，非侵袭性癌，肿瘤细胞未侵犯基底层，上皮内瘤变，细胞不典型性增生等；

b.交界性肿瘤，交界恶性肿瘤，肿瘤低度恶性潜能，潜在低度恶性肿瘤等。

2）较轻急性心肌梗死

急性心肌梗死指由于冠状动脉闭塞或梗阻引起部分心肌严重的持久性缺血造成急性心肌坏死。急性心肌梗死的诊断必须依据国际国内诊断标准，符合（1）检测到肌酸激酶同工酶（CK-MB）或肌钙蛋白（cTn）升高和/或降低的动态变化，至少一次达到或超过心肌梗死的临床诊断标准；（2）同时存在下列之一的证据，包括：缺血性胸痛症状、新发生的缺血性心电图改变、新生成的病理性 Q 波、影像学证据显示有新出现的心肌活性丧失或新出现局部室壁运动异常、冠脉造影证实存在冠状动脉血栓。

较轻急性心肌梗死指依照上述标准被明确诊断为急性心肌梗死，但未达到“较重急性心肌梗死”的给付标准。

其他非冠状动脉阻塞性疾病引起的肌钙蛋白（cTn）升高不在保障范围内。

3）轻度脑中风后遗症

指因脑血管的突发病变引起脑血管出血、栓塞或梗塞，须由头颅断层扫描（CT）、核磁共振检查（MRI）等影像学检查证实，并导致神经系统永久性的功能障碍，但未达到“严重脑中风后遗症”的给付标准，在疾病确诊 180 天后，仍遗留下列至少一种障碍：

（1）一肢（含）以上肢体肌力为 3 级；

（2）自主生活能力部分丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的两项。

上述三种轻度疾病依照中国保险行业协会制定的《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020 年修订版）》标准定义，其他轻度疾病依照本附加合同约定定义。

4）较小面积Ⅲ度烧伤

指烧伤程度为Ⅲ度，且Ⅲ度烧伤面积达到全身体表面积的 10%但少于 20%，且未达到重度疾病“严重面部烧伤”的给付标准。体表面积根据《中国新九分法》计算。

5）深度昏迷 48 小时

指因疾病或意外伤害导致意识丧失，对外界刺激和体内需求均无反应，昏迷程度按照格拉斯哥昏迷分级（GCS，Glasgow Coma Scale）结果为 5 分或 5 分以下，且已经持续使用呼吸机及其他生命维持系统 48 小时（含）以上但未超过 96 小时。**本附加合同所保障的“深度昏迷 48 小时”需在开始使用呼吸机及其他生命维持系统超过 96 小时后申请理赔，对于理赔申请提出时已经符合重度疾病“深度昏迷”给付标准的，我们不承担本项“深度昏迷 48 小时”的保险责任。**

因酗酒或药物滥用导致的“深度昏迷 48 小时”不在保障范围内。

6）轻度面部烧伤

指面部烧伤程度为Ⅲ度，且Ⅲ度烧伤的面积达到面部表面积的 30%或以上，但未达到重度疾病“严重面部烧伤”的给付标准。

7）轻度再生障碍性贫血

指因骨髓造血功能慢性持续性衰竭导致的贫血、中性粒细胞减少及血小板减少。须满足下列至少一项条件，但未达到重度疾病“重型再生障碍性贫血”的给付标准：

（1）骨髓刺激疗法至少一个月；

（2）免疫抑制剂治疗至少一个月。

8）急性肾功能衰竭肾脏透析治疗

急性肾功能衰竭（ARF）或称急性肾损伤（AKI），是指各种病因引起的肾功能在短期内（数小时或数周）急剧进行性下降，导致体内氮质产物尿液潴留而出现的临床综合征，但未达到重度疾病“严重慢性肾衰竭”的标准。

本附加合同所保障的“急性肾功能衰竭肾脏透析治疗”指被明确诊断为急性肾功能衰竭并且满足下列所有条件：

（1）少尿或无尿 2 天以上；

（2）血肌酐（Scr）>5mg/dl 或>442μmol/L；

（3）血钾>6.5mmol/L；

（4）接受了血液透析治疗。

9）外伤性全脾切除手术

指因严重腹部外伤导致脾破裂，已经实施了全脾切除手术。**单纯脾修补术和脾部分切除术不在保障范围内，因外伤以外原因导致的全脾切除术不在保障范围内。**

10）轻度坏死性筋膜炎

是一种由细菌侵入皮下组织和筋膜引起的急性坏死性软组织感染，可伴有毒血症、败血症、中毒性休克、弥漫性血管内凝血及多器官衰竭。须经相关专科医生明确诊断，但未达到重度疾病“重症急性坏死性筋膜炎”的给付标准。

（此页内容结束）